RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL

(JULHO/2020 A FEVEREIRO/2021)



Saúde do trabalhador e a covid-19

GPST
CNPq
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Coordenadores

Thaís Máximo
Tatiana Torres
Adson Cunha
Marcus Carvalho

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL

(JULHO/2020 A FEVEREIRO/2021)



Saúde do trabalhador e a covid-19

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENADORA
Thaís Máximo

VICE-COORDENADORA
Tatiana Torres

COORDENADOR DE TI
Adson Cunha

COORDENADOR DE TI
Marcus Carvalho

ASSISTENTES

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ulisses Nascimento

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Suéllen Rodrigues

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA E PESQUISA DE CAMPO
Valéria Nicolau

LÍDER TÉCNICO DO NÚCLEO DE TI
Walterlly Nicolau de Sousa

BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO

CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS E MAPEAMENTO DAS REDES DE SINDICATOS DE PROFISSIONAIS
Maria Beatriz Medeiros e Wesley Silva

CONSTRUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Daniely Santana

DESENVOLVIMENTO BACK-END WEB E MOBILE
Arthur Cavalcante

DESENVOLVIMENTO FRONT-END WEB E MOBILE
Kawhan Laurindo

DESIGN DE INTERFACES WEB E MOBILE
Relbert Medeiros

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA E MATERIAL DOCUMENTAL SOBRE A COVID-19
Maria Luiza Lopes e Rian Enedino

MAPEAMENTO DE REDE DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO À COVID-19 NO NORDESTE
Eduarda Dias, Lígia Ferraz e Lucas Vasconcelos

MÍDIAS DIGITAIS
Gabrielly Nascimento



APRESENTAÇÃO

Ainda no primeiro semestre de 2020, o Grupo de Pesquisa Subjetividade e Trabalho (GPST), vinculado à Universidade Federal da Paraíba, que atua com pesquisa, extensão e ensino no contexto das organizações de trabalho, e que, há tempos, acompanha a situação dos trabalhadores da saúde, mobilizou debates a respeito das possibilidades que o grupo poderia encontrar no sentido de contribuir para amenizar as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores, sobretudo aqueles que se encontravam na "linha de frente" no combate à doença. Começamos a atuar no início da pandemia no Brasil, com a produção e publicação da cartilha "Trabalhadores(as) da saúde em foco: reconhecimento e saúde no trabalho", pela EDUFPB. A mesma traz reflexões sobre o trabalho na saúde em tempos de pandemia, propondo possibilidades de intervenção.

Nesse mesmo período, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério das Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações (MCTIC), lançou uma chamada de pesquisas para o enfrentamento da covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. E assim submetemos e tivemos a aprovação do projeto intitulado "A saúde dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia da covid-19: prevenção e cuidado".

O presente relatório técnico parcial objetiva informar aos nossos financiadores (CNPq/MCTIC), e também ao Ministério da Saúde, a situação atual do projeto de pesquisa e seus resultados parciais. O projeto foi iniciado em julho de 2020 e deve ser finalizado em 2022. Portanto, este primeiro relatório reflete as ações realizadas no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021.

Durante o segundo semestre de 2020 e início de 2021, a equipe do projeto se debruçou sobre o tema dos trabalhadores da saúde e o enfrentamento à covid-19. Para tanto, alguns eixos de ação foram desenvolvidos:

(a) mapeamento da covid-19 no Nordeste: o projeto se debruçou em buscar os índices de adoecimentos de forma geral nos estados do Nordeste, adoecimentos de trabalhadores da saúde, instituições de referência e categorias profissionais envolvidas. Esse eixo teve por finalidade nos aproximarmos da realidade da covid-19 no Nordeste, buscando compreender as redes de atendimento e assistência na região. Tal estudo fez-se necessário por dois aspectos. Primeiro, para reunirmos dados da população dos trabalhadores de saúde no Nordeste, a partir das instituições de referência para covid-19, que serão importantes para definição da amostra do nosso estudo quantitativo II.

Segundo, para reunirmos informações para alimentar as plataformas que serão produto deste projeto: observatório e aplicativo;

(b) revisão sistemática da literatura nacional e internacional sobre saúde mental, segurança no trabalho, covid-19 e trabalhadores da saúde no ano de 2020;

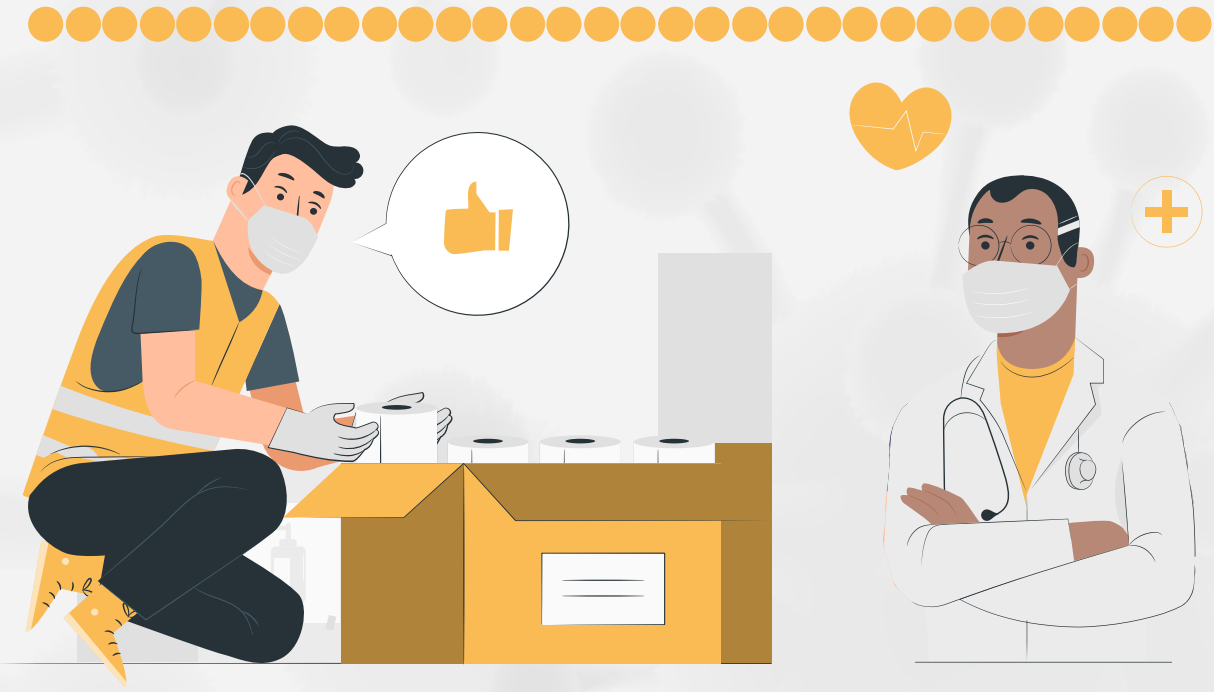
(c) elaboração de protocolo de pesquisa dentro dos padrões éticos, submissão e aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa sob o protocolo CAAE 38746420.0.0000.5188;

(d) contato com pesquisadores parceiros: processo que envolveu a equipe no sentido de construir uma rede com pesquisadores do Nordeste para que os nossos estudos possam chegar aos diferentes estados. Esses contatos culminaram com a consolidação de parcerias junto a diferentes grupos de pesquisa e instituições do Nordeste e com a reunião geral com os parceiros em dezembro de 2020;

(e) elaboração, realização e análise preliminar de Estudo I (quantitativo exploratório) em todos os estados do Nordeste;

(f) composição das equipes de Tecnologia da Informação (TI) e delineamento dos produtos do projeto de pesquisa.

O nosso relatório reflete resultados iniciais e ainda não conclusivos, mas pretende encaminhar sugestões de ações em políticas e gestão pública em saúde, por considerar que o contexto da pandemia requer dinamicidade por parte dos pesquisadores.



SUMÁRIO

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 8

REVISÃO DE LITERATURA E DOCUMENTAL 13

CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 18

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO 21

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26

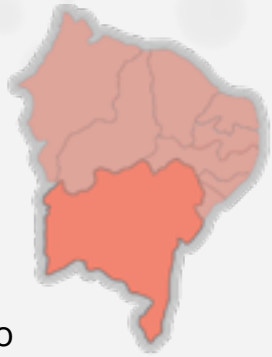
APLICABILIDADE PARA O SUS 28

REDES SOCIAIS E CONTATOS 30

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL

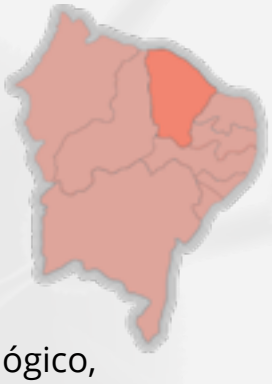
A pesquisa de mapeamento de instituições e profissionais do SUS nos estados do Nordeste teve como objetivo principal buscar por dados sobre a realidade dos profissionais do SUS que trabalham ou trabalharam na linha de frente durante a pandemia. Iniciamos as buscas na tentativa de concluir números para o total de profissionais atuantes e a porcentagem dos adoecimentos e óbitos, entre eles, para as áreas profissionais mais adoecidas e para o total de instituições, por estado, que atendam ou notifiquem pacientes com covid-19. Nisso, buscamos por notícias oficiais dos governos dos estados, por dados publicados pelo IBGE e pela divulgação dos Boletins Epidemiológicos Estaduais. Com isso, nos deparamos com a falta de consistência e de padronização nos dados divulgados pelos nove estados da região, até o mês de outubro de 2020, principalmente no que se refere ao detalhamento sobre essa categoria profissional e à discriminação entre os dados que dizem respeito ao SUS ou à rede privada de saúde.

Bahia



Na experiência de pesquisa pelo estado da Bahia, não foram encontrados dados a respeito da quantidade de profissionais de saúde atuantes na linha de frente da covid-19, bem como o número de profissionais contaminados. As informações disponíveis na Central Integrada de Comando e Controle da Saúde do Governo do Estado forneciam dados apenas a respeito da ocupação de leitos, da enfermaria adulta e da UTI adulta. A Secretária de Saúde do Estado fornece também uma tabela com todas as unidades de referência para covid-19.

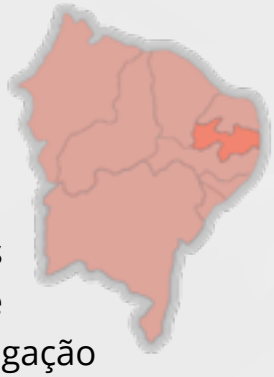
Ceará



O governo do Estado do Ceará, por sua vez, fornece, através do IntegraSus (2020), dados importantes sobre a quantidade de profissionais de saúde contaminados pela covid-19 com detalhamento segundo a categoria profissional. Além disso, é disponibilizado por meio do boletim epidemiológico,

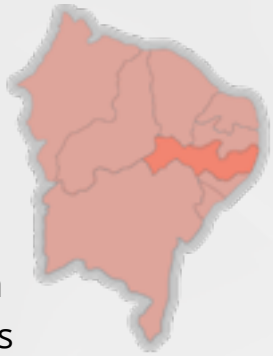
atualizado todos os dias, dados a respeito de casos notificados, confirmados, recuperados, número de exames realizados, entre outros. Nessa busca, os dados também podem ser encontrados por município.

Paraíba



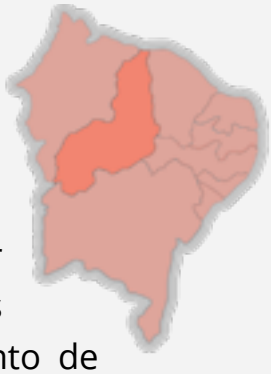
Ao se tratar da Paraíba, identificamos que os boletins epidemiológicos são divulgados quinzenalmente, mas não trazem muitas especificidades sobre os casos de adoecimentos dos profissionais de saúde — a quantidade de óbitos, por exemplo, não é divulgada. Apesar disso, há ampla divulgação sobre as Unidades de Referência e quantidades de leitos disponíveis no estado.

Pernambuco



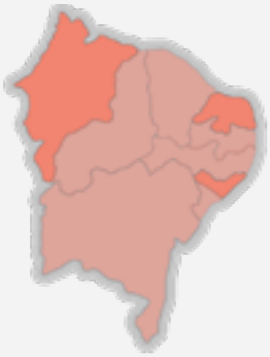
Já os boletins publicados pelo Governo do Estado de Pernambuco são muito objetivos, publicados diariamente, e detalham os dados sobre essa classe de profissionais semanalmente, reunindo informações coletadas a partir de 12 de março de 2020. Há, dentre esse grupo populacional, dados sobre testagem, sobre casos confirmados e recuperados, óbitos, informações distribuidas por sexo, por faixa etária e por categoria profissional. A identificação das Unidades de Referência distribuídas não é clara, então, para obter esses dados, contactamos a Secretaria de Saúde por telefone e por e-mail, sem retorno.

Piauí



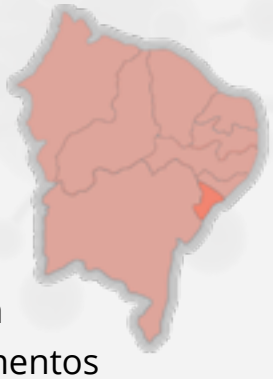
Já, no Piauí, os dados relacionados à covid-19 concentram-se apenas em números de infecções e óbitos, contemplando todo o estado, sem existir uma separação de grupos por casos de infecção. No entanto, em boletins divulgados pelo Estado, é possível verificar a quantidade de equipamento de proteção individual (EPIs) que são distribuídos aos profissionais de saúde atuantes na linha de frente. Com relação aos casos de adoecimento de profissionais de saúde, não foi encontrada essa informação nos boletins do próprio estado.

Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte



Os estados do Maranhão (MA) e Rio Grande do Norte (RN) se assemelham na forma de divulgação e na criação de portais para divulgação dos dados sobre a covid, sendo eles: o Portal da Transparência do RegulaRN (LAIS/IFRN), que tem como objetivo ser a fonte oficial de dados relacionados à regulação de leitos de covid-19 do RN, e o Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde do Maranhão. O estado de Alagoas chama a atenção por divulgar também, além do percentual de ocupação de leitos, que é comum a todos os estados, em planilhas de dados abertas, um perfil dos profissionais de saúde adoecidos, recuperados e que vieram a óbito.

Sergipe



Por fim, em Sergipe, no boletim informativo divulgado pelo Estado, não há a presença de um quantitativo de profissionais atuantes na linha de frente contra a covid-19 e, igualmente, não apresenta casos de adoecimentos desse grupo. Os dados concentram-se apenas no número de casos (recuperação e óbitos), assim como também exames realizados para a detecção do vírus. Apesar de todas essas divergências na divulgação de dados, vale ressaltar a divulgação de boletim epidemiológico pelo Governo Federal (BRASIL, 2020), no qual é possível localizar dados sobre adoecimento, óbito e a profissão da saúde que foi mais afetada pelo vírus da covid-19, além da plataforma LocalizaSUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020), que é uma ferramenta que divulga dados como distribuição de EPIs, de testes e de medicamentos, vacinação e dados sobre epidemiologia por região, estado e município — embora não haja detalhamento sobre os profissionais de saúde.

Conclusões

Tendo em vista essas dificuldades, partimos para outro método de coleta, a partir das bases de dados do Ministério da Saúde, sendo elas: o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para os dados do CNES, foi calculada a quantidade de profissionais de saúde

que atuam em cada estabelecimento de saúde, agrupado por diferentes características, enquanto, para os dados de SRAG, foi calculada a quantidade de notificações de covid-19 realizadas por cada estabelecimento de saúde.

Após os cálculos individuais em cada tabela, os dados foram agrupados(as) numa tabela resultante. A pesquisa, então, se concentrou nas microrregiões das capitais de cada estado, a partir das definições do IBGE (2019) — sendo assim, as capitais (municípios sede) e seus municípios limítrofes. O objetivo da busca foi a quantidade de profissionais de saúde do SUS e a quantidade de notificações da covid-19 em cada instituição de saúde desses municípios selecionados, possibilitando visualizar quantas e quais instituições são essas. Os filtros de busca foram padronizados da seguinte forma: (a) UF (Estado); (b) municípios; (c) tipos de estabelecimento: ambulatório, hospital, pronto atendimento, Unidade Básica de Saúde e Unidade de Atenção Domiciliar — sendo esses, os que atendem e lidam diretamente com o público adoecido de covid-19; (d) natureza jurídica: estabelecimentos do poder público; (e) unidade (lista das instituições selecionadas). Posteriormente, foram excluídas as instituições de saúde públicas que não fazem parte do Sistema Único de Saúde (por exemplo, hospitais navais, cujo poder é das Forças Armadas). Os principais dados obtidos foram:

Tabela 1. Profissionais e instituições do SUS e notificações de covid-19.

UF	Total de profissionais do SUS (microrregião)	Total de instituições SUS (microrregião)	Total de notificações de covid-19 (microrregião)
AL	8.449	11	46.221
BA	11.360	30	47.790
CE	23.420	29	189.979
MA	14.493	22	41.716
PB	2.166	19	26.899
PE	12.948	28	76.089
PI	6.349	12	51.283
RN	10955	18	51506
SE	5.460	5	69.317

Fonte: Produção própria

Referências

BRASIL. Coronavírus Brasil. Covid.saude.gov.br. 2020. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 5 fev. 2021

CENTRAL INTEGRADA DE COMANDO E CONTROLE DA SAÚDE. Disponível em: https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/. Acesso em: 1 dez. 2020.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. IntegraSUS. Transparência da Saúde do Ceará. 2020. Disponível em: https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/coronavirus-ceara. Acesso em: 2 dez. 2020.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. Secretaria de Saúde. Covid-19 no Maranhão. Disponível em: https://painel-covid19.saude.ma.gov.br/. Acesso em: 5 fev. 2021.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Index of /organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2019. Disponível em: http://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2019/. Acesso em: 5 dez. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Governo Federal. 2020. Localiza SUS [*on-line*]. Disponível em: https://localizasus.saude.gov.br/. Acesso em: 5 fev. 2021.

NAVI/IFRN, LAIS/UFRN. RegulaRN. Regulacao.saude.rn.gov.br. Disponível em: https://regulacao.saude.rn.gov.br/sala-situacao/sala_publica/. Acesso em: 5 fev. 2021.

REDE DE ATENDIMENTO À COVID-19 NA BAHIA. Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/atendimentocovid19/. Acesso em: 27 nov. 2020.

REVISÃO DE LITERATURA E DOCUMENTAL



Trabalhadores da saúde e covid-19: revisão sistemática, integrativa e metanálise qualitativa sobre saúde mental e segurança no trabalho.



Resultados preliminares

A pesquisa de revisão da literatura e documental contou com a colaboração de três alunos de iniciação científica vinculados ao nosso projeto financiado pelo CNPq: "A saúde dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia da covid-19: prevenção e cuidado".

A presente pesquisa de revisão da literatura se dividiu em dois estudos complementares e concomitantes. O primeiro estudo objetivou caracterizar (delineamento, métodos, resultados) estudos científicos publicados em língua inglesa até outubro de 2020, com foco no tema da saúde mental e segurança no trabalho para trabalhadores da saúde no contexto da pandemia pela covid-19. O segundo teve o objetivo de caracterizar, de forma mais integrativa, artigos científicos e documentos institucionais, publicados em língua portuguesa, no mesmo período e com o mesmo foco que o Estudo 1.

O primeiro estudo apresentou método de revisão sistemática e análise cientométrica, com base em artigos científicos disponíveis na base *Google Scholar*; e, o segundo, com delineamento de análise documental de material institucional proveniente de organizações, instituições de pesquisa e órgãos públicos, que se somou aos artigos científicos disponíveis nas bases *Scielo* e *Google Scholar*, com foco na mesma temática: covid-19, saúde mental e segurança no trabalho para trabalhadores da saúde.

O material selecionado foi avaliado por três juízes técnicos que, com base em critérios de inclusão e exclusão, chegaram a 21 artigos em inglês, 12 artigos em português e 27 documentos (publicações institucionais) que versavam sobre a temática da pesquisa. Como resultados, identificamos o que apresentamos a seguir.

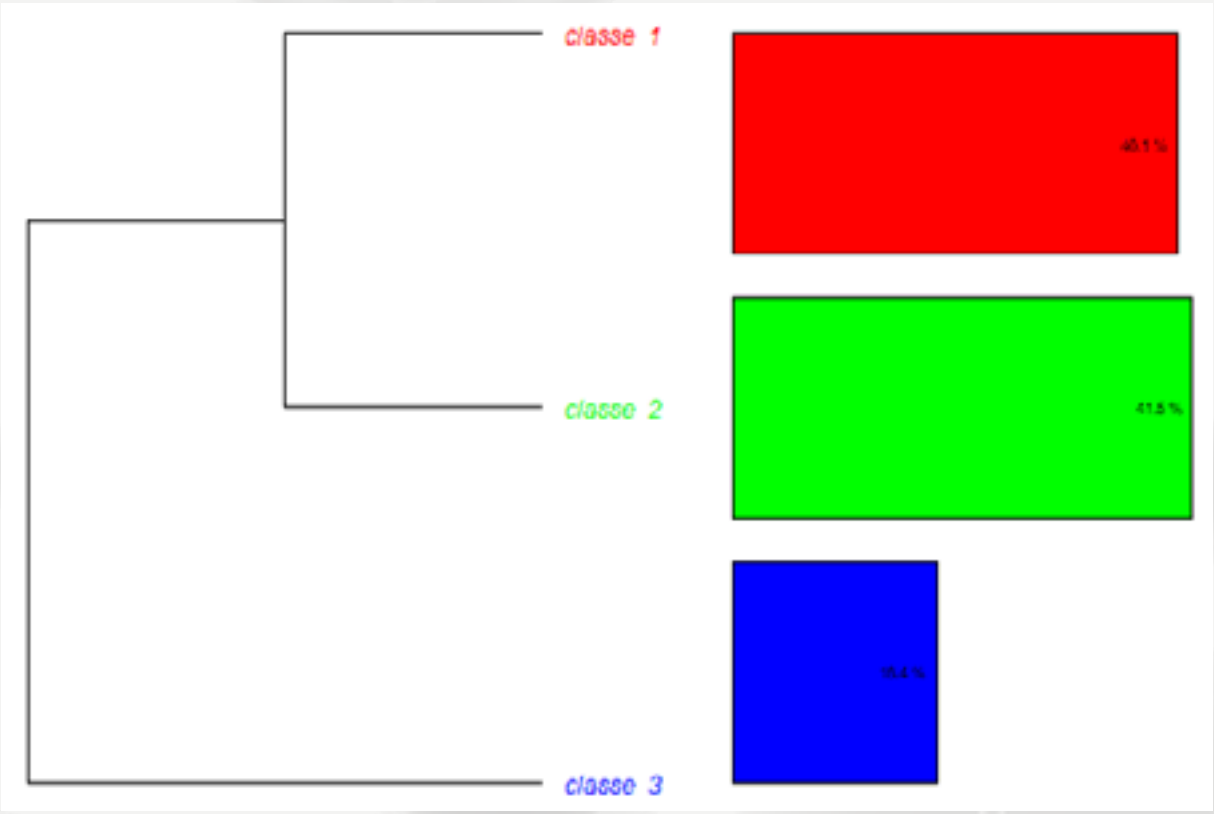
Estudo 1

Há participação de muitos autores (120), de diferentes instituições (49) e nacionalidades, indicando que, no contexto das publicações científicas internacionais, houve compartilhamento de informações e cooperação entre pesquisadores e instituições.

Como o primeiro caso de covid-19 surgiu em Wuhan, no final de 2019, era esperado que as publicações ocorressem a partir de meados de 2020. Nós observamos que houve maior centralização no segundo semestre de 2020. As revistas onde os artigos foram publicados eram muito qualificadas e reconhecidas cientificamente. Os pesquisadores da área da saúde foram maioria entre os autores.

Na análise lexicográfica, identificamos que houve maior heterogeneidade no conteúdo dos artigos. Apenas três classes foram geradas no dendrograma (Figura 1), com destaque para uma classe que agrupou os estudos quantitativos, em que foi possível identificar que: gênero (mulheres) e idade (jovens) relacionaram-se com incidência de infecção pela covid-19 e com transtornos em saúde mental (depressão, *Burnout*) entre os trabalhadores da saúde. Nas outras duas classes, a análise apresentou as condições, processos e organização do trabalho atrelados ao adoecimento dos profissionais, seja pela covid-19 ou por problemas de saúde mental.

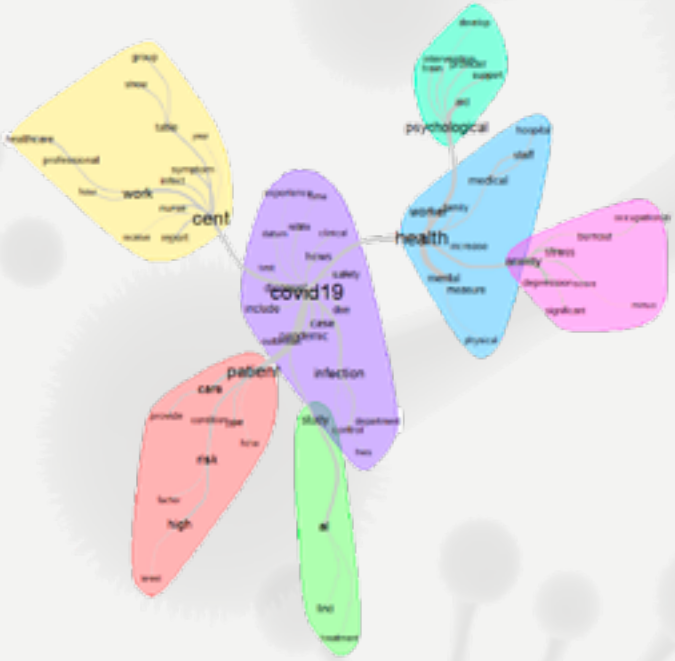
Figura 1. Dendrograma da análise dos artigos em inglês.



Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

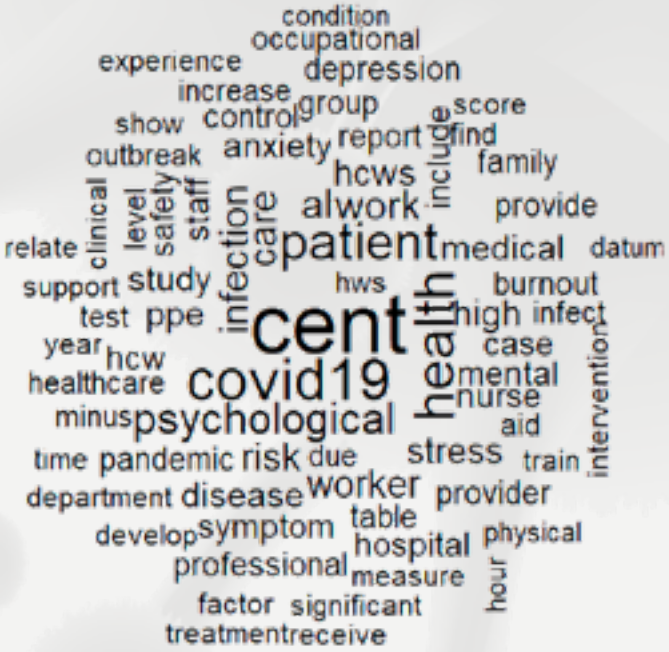
Na análise de similitude — grafos de árvores (Figura 2), houve forte conexão entre covid-19 – *cent*, indicando os dados estatísticos dos estudos quantitativos de levantamento, e também entre covid-19, paciente (*patient)* e saúde (*health*), sendo o primeiro relacionado com cuidado (*care*) e o segundo com trabalhador (*worker*), o que nos leva a inferir que a saúde, na imagem, é a saúde dos trabalhadores e não dos pacientes. Inclusive, estes últimos são vistos como o grande risco de infecção para os profissionais da saúde, mas, ao mesmo tempo, precisam de seus cuidados. Chama nossa atenção um núcleo de palavras que se agregam em torno de saúde mental (*mental health*) e que indicam alguns transtornos e síndromes psicológicas.

Figura 2. Árvore de grafos da análise de artigos em inglês.



Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

Figura 3. Nuvem de palavras artigos em inglês.



Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

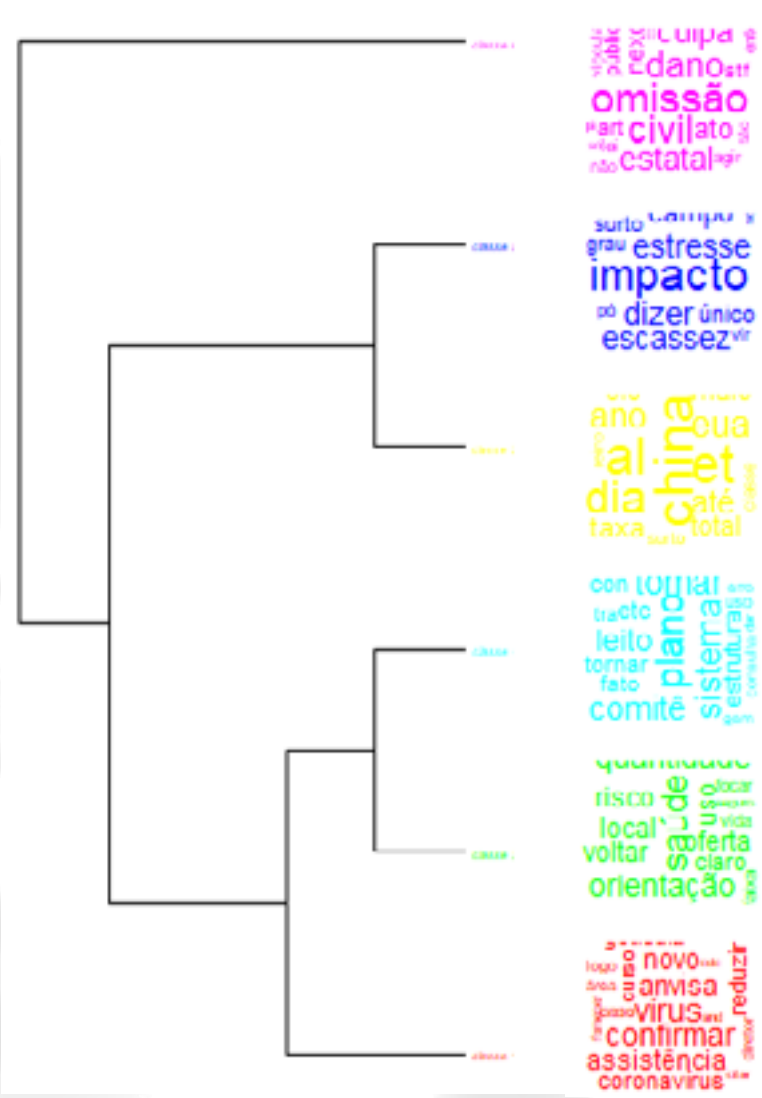
Estudo 2

Diferente dos resultados internacionais, nos estudos nacionais percebemos pouca articulação entre instituições, áreas, pesquisadores e localidades. Isso pode ser explicado pelo tema recente e pela maior dificuldade de publicação rápida no Brasil. No entanto, é preciso evidenciar a importância do número especial da Revista de Saúde Ocupacional, que numa única publicação trouxe três estudos sobre a temática. Mesmo assim, as publicações nacionais foram pouco qualificadas — muitos dos artigos selecionados não

possuem índice na avaliação qualis-Capes.

Nas análises lexicográficas, o dendrograma (Figura 4) mostra que a classe 6 *(Responsabilidade do Estado e direito dos trabalhadores)* se opõe a todas as outras classes, demonstrando que, nos artigos, há uma separação nos textos entre o Direito e as situações relacionadas aos trabalhadores da saúde e a covid-19 (*Infecção dos profissionais de saúde, saúde mental dos trabalhadores, contaminação e controle, saúde e segurança no trabalho, tomada de decisão e resposta à pandemia)*.

Figura 4. Dendrograma com nuvens de palavras por classe.

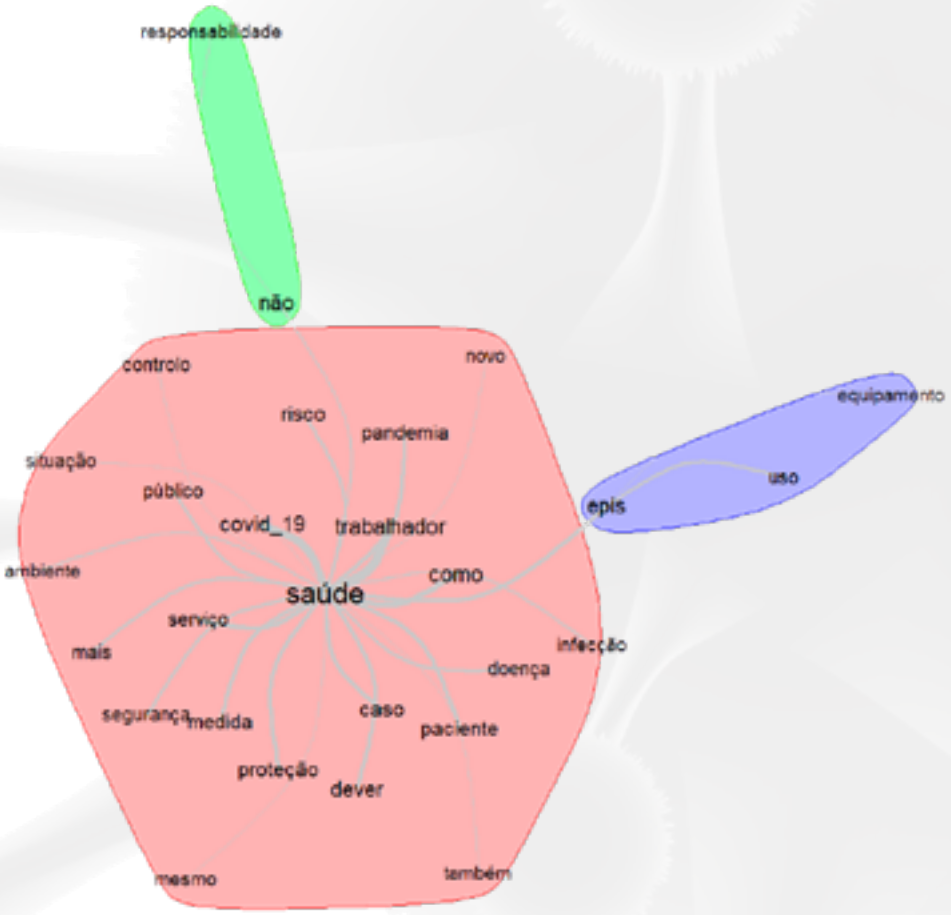


Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

Na análise de similitude (Figura 5), a palavra organizadora foi *saúde*, tanto por serem trabalhadores da saúde, como por se tratar de um problema de saúde pública (covid-19), quanto por revelarem preocupação com a saúde dos trabalhadores. Chamou nossa atenção as palavras com maior coocorrência com *saúde*. Foram elas: *trabalhador, covid-19, dever, como* e *não.* O "como" podendo ser interpretado por: como? Uma pergunta que acompanha o cotidiano dos trabalhadores da saúde. Como não se infectar? Como se proteger? Como conseguir realizar um trabalho bem feito? Como atender melhor os pacientes? Como lidar com o estresse e a tensão do dia a dia do trabalho?

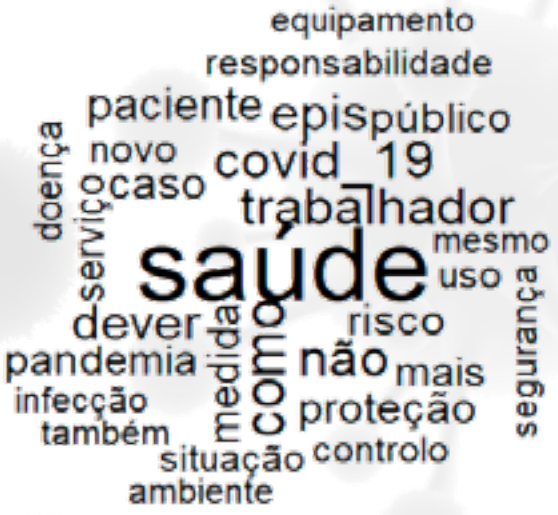
A palavra "dever" indica o quanto os trabalhadores da saúde se sentem responsáveis pelo trabalho, mas também o quanto o Estado tem o "dever" de protegê-los. E o "não" aparece relacionado à responsabilidade, no caso, à irresponsabilidade da sociedade civil que continua se omitindo diante da pandemia e causando danos ao coletivo de pessoas. Outro agrupamento mostra forte conexão entre as palavras: *uso, equipamento* e *EPIs,* indicando a preocupação com a segurança no trabalho.

Figura 5. Árvore dos grafos da análise de artigos em português.



Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

Figura 6. Nuvem de palavras com base na análise de artigos científicos em português.



Fonte: Produção própria com uso do *software* Iramuteq (2021)

Na nuvem de palavras, nos chama a atenção as palavras: *EPI, paciente, caso, risco* e *pandemia*, que, juntamente com as palavras *não, medida, trabalhador, proteção, covid-19, dever, serviço* e *situação*, demonstram como as palavras mais frequentes se organizam.

Nos documentos institucionais divulgados sobre o tema saúde mental e segurança no trabalho dos profissionais de saúde no contexto da covid-19, destaca-se: OPAS (5), Ministério da Saúde (4) e Fiocruz (4). Além disso, observamos que as cartilhas são muito utilizadas como divulgação científica.

CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA



A princípio, em nosso projeto submetido ao edital, teríamos apenas dois estudos a serem desenvolvidos: um quantitativo, a ser aplicado presencialmente em unidades de saúde referência para covid-19 no Nordeste; e outro qualitativo, para que pudéssemos aprofundar as vivências desses sujeitos e sua relação com o trabalho. Contudo, ao iniciarmos o projeto, analisando o cenário da pandemia, vimos a necessidade de algo que fosse prontamente realizado, um estudo exploratório, para que conseguíssemos mapear quem são os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. Por isso, surgiu esse estudo exploratório que será brevemente descrito a seguir. Como finalizamos a coleta desse primeiro estudo dia 28 de fevereiro de 2021, apresentaremos resultados ainda preliminares acerca dos participantes.

O instrumento foi desenvolvido para a realização do Estudo I de nossa pesquisa, este tendo como objetivos analisar as concepções de saúde e segurança do trabalho para profissionais que atuam no campo da saúde. O público-alvo do questionário foram trabalhadores do campo da saúde e que atuam ou atuaram em instituições do SUS de combate à pandemia da covid-19 no Nordeste.

Foi utilizada a plataforma *Google Forms* para a aplicação do instrumento, pois, devido ao contexto da pandemia da covid-19, foi necessário que a aplicação do questionário acontecesse de forma remota. As perguntas foram elaboradas com o propósito de investigar o perfil dos profissionais envolvidos no enfrentamento ao coronavírus, como: qual o tipo de contrato; onde esses trabalhadores atuam ou atuaram; se foram infectados ou não; se foram disponibilizados EPIs, e se estes eram suficientes; se foi oferecido treinamento ou ações voltadas para a saúde mental; quais as condições de trabalho proporcionadas; e também qual o sentido de trabalhar no enfrentamento à pandemia para os respondentes.

Até chegarmos à versão final do instrumento, foram necessárias diversas reuniões com a equipe de pesquisa. A elaboração do questionário teve início no mês de agosto de 2020, quando foram dadas as primeiras instruções, e, no final deste mesmo mês, foram realizados os primeiros ajustes, após reunião com o grupo. Já no mês de setembro de

2020, foi feita uma revisão ortográfica para que depois o questionário fosse enviado para duas juízas avaliarem. No início de outubro de 2020, foi recebido o instrumento com todos os apontamentos e correções das juízas e, ainda no fim de outubro, foi iniciada a aplicação-teste. Após essa primeira aplicação, com um grupo reduzido de participantes, foram efetuadas as alterações finais, no começo de novembro. No dia 23 de novembro de 2020, foi o início da aplicação da versão final do instrumento, que se estendeu até o dia 28 de fevereiro de 2021.

Participaram desse primeiro estudo exploratório 242 trabalhadores da saúde, sendo 27,3% enfermeiros; 12,4% técnicos de enfermagem; 9,5% psicólogos; 9,1% fisioterapeutas; 9,1% farmacêuticos; 7,9% agentes comunitários de saúde; 7,4% médicos; 7% assistentes sociais; 4,5% nutricionistas; e outras categorias profissionais que também contribuíram com menores índices de resposta, a saber: recepcionistas, maqueiros, condutores de ambulância, biomédicos, cozinheiro, técnico em radiologia e gerente.



Dentre os que participaram, 84,3% foram do sexo feminino e 15,7% do sexo masculino. As idades variaram de 21 a 75 anos, com maior prevalência na faixa etária de 33 anos. 49,6% se declararam pardos, seguidos de 37,6% que se declararam brancos; 9,1% pretos; e 3,7% amarelos.

Com relação aos estados, 50,8% dos que participaram foram da Paraíba; seguidos de 11,6% de Pernambuco; 9,5% do Rio Grande do Norte; 8,7% da Bahia; 5,8% do Ceará; 4,1% do Piauí, Alagoas e Maranhão; e 3,7% de Sergipe.

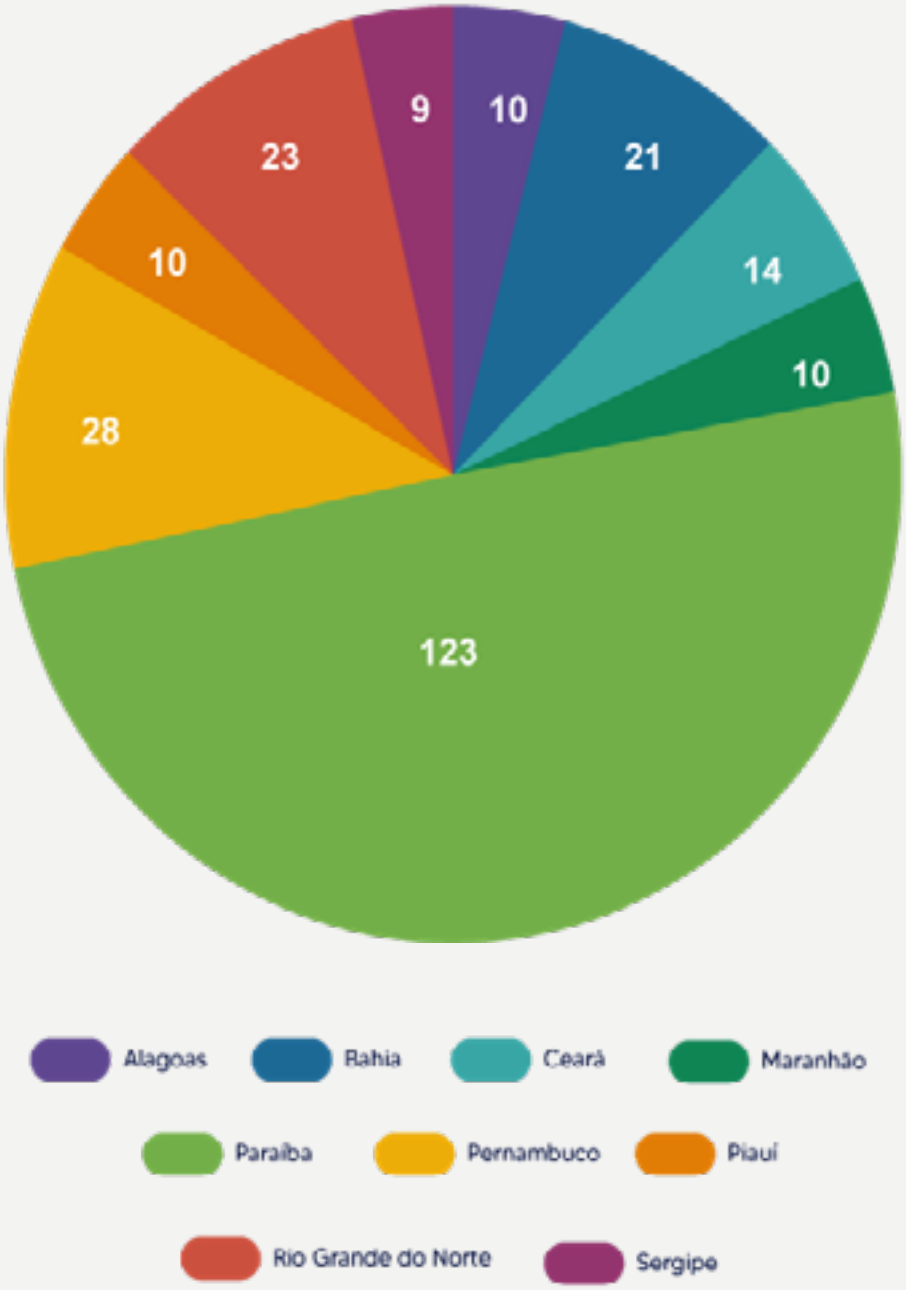
Os percentuais somam mais de 100%, nesse e em outros casos, porque os respondentes podiam escolher mais de uma opção. Dessa forma, alguns relataram atuação em mais de um estado, em mais de um tipo de instituição ou de vínculo.

No que se refere às instituições de atuação, tivemos 57% em hospitais públicos; 35,5% na atenção primária; 8,7% em hospitais de campanha; 6,2% em UPAs; e 4,2% em Samu, seguidos de outros estabelecimentos que tiveram baixa representatividade.

Quanto aos vínculos empregatícios, 46,8% disseram ser efetivos; 23,6% contratos por tempo determinado; 14% contratos sem tempo determinado; 13,2% contratos diretamente com a secretaria de saúde; 5,8% empregados celetistas (fundação pública); 4,1% celetistas de empresas privadas; e ainda apareceram vínculos como autônomos (pessoa física, pessoa jurídica e cooperados) e contratados verbalmente.

Outros resultados estão sendo analisados por nossa equipe de pesquisa e, em breve, divulgaremos em formato de relatório, publicações científicas, bem como nas nossas redes sociais.

Gráfico 1. Distribuição de respondentes ao Estudo I por estado.



Fonte: Produção própria.

Redes sociais e *lives*

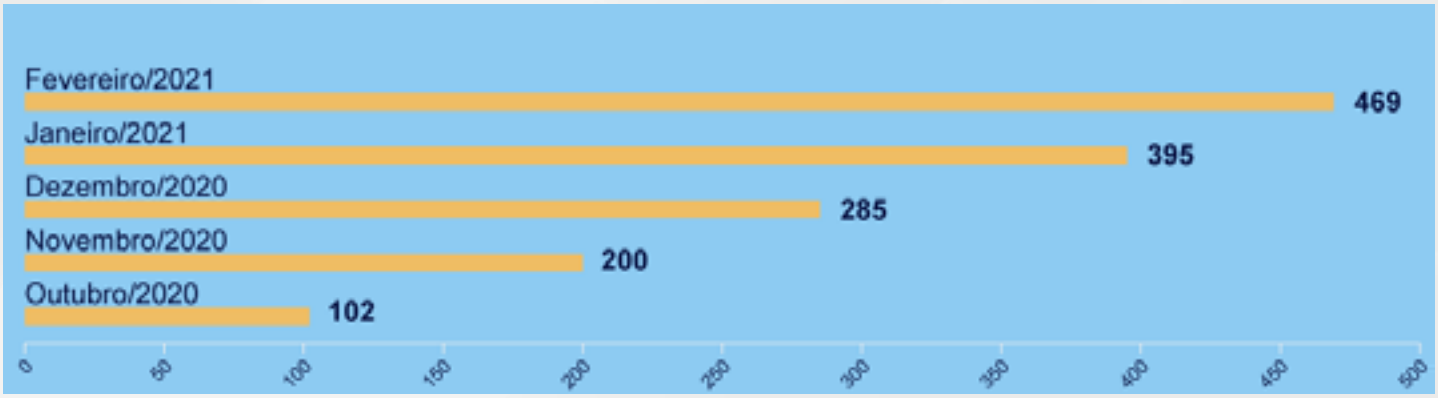
O núcleo de comunicação foi formado em meados do mês de setembro de 2020, com o ingresso no projeto de uma jornalista e de uma bolsista de graduação da área de Mídias Digitais. Em 1 de outubro de 2020, entrou no ar nosso primeiro perfil em rede social, no *Instagram* (@saudedotrabalhador_covid19), que ainda se configura como nosso principal canal de comunicação, contabilizando, no último dia de fevereiro de 2021, 469 seguidores.





Com um planejamento de comunicação que visa conservar o perfil vivo, captando, mantendo seguidores e possibilitando interações, são feitas publicações autorais semanais, em *feed* e *stories*, além de *reposts* com temas da área de interesse do projeto, a fim construir uma base de pessoas que acompanhem o nosso perfil, ofertar informações relevantes relacionadas aos temas trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores da saúde e estreitar laços com entidades representativas e instituições relacionadas à atuação de trabalhadores da saúde, que podem ser parceiras na divulgação da realização de nossos estudos e dos resultados da pesquisa.

Gráfico 2. *Instagram* – número de seguidores mês a mês.



Fonte: Produção própria.

Foi por meio do *Instagram* que pudemos divulgar junto aos nossos seguidores a nossa participação em eventos, como, em outubro de 2020, no Seminário Marco Zero, *Pesquisas para o enfrentamento da covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias*, quando apresentamos nossa pesquisa e a discutimos junto a outros pesquisadores; e, no mesmo mês, a participação de nossa coordenadora, Thaís Máximo, no Colóquio Nacional de Psicologia Social da Saúde 2020, em mesa sobre *Relações de trabalho e pandemia: adaptações e impactos*; e em webinário da CUT, com o tema *Os impactos da pandemia na saúde mental das trabalhadoras.*



O contato com instituições representativas, entidades sindicais e conselhos profissionais da região Nordeste foi realizado também por telefone e envio de *e-mails*, solicitando apoio para que nos auxiliassem na divulgação da realização do primeiro estudo da pesquisa junto aos trabalhadores que representam, aplicação remota que ocorreu de novembro de 2020 a fevereiro de 2021.

Para divulgação do Estudo I, foram criadas diversas peças, em imagem e vídeo, divulgadas, sobretudo, por meio de nossos perfis no *Instagram* e *Facebook*. A criação do perfil no *Facebook* (*Saúde do trabalhador e a covid-19*) ocorreu em outubro de 2020, a fim de ampliarmos o alcance de divulgação, possibilitando que tivéssemos inserção também dentro de grupos da referida rede social formados pelo público de nosso interesse, ou seja, os trabalhadores da saúde de diferentes categorias.





Em novembro de 2020, criamos o canal *Subjetividade e Trabalho,* no *YouTube*, que atende ao Grupo de Pesquisa Subjetividade e Trabalho (GPST), do qual fazemos parte. Por meio do canal, pudemos realizar *lives* com convidados, ocasiões muito importantes para debatermos questões de interesse de nossa pesquisa, conteúdo que permanece disponível para que possa ser assistido posteriormente e que trabalhamos, em formato mais breve, também em nossas outras redes sociais.

A primeira *live* foi realizada no dia 11 de novembro de 2020, sobre *Saúde mental e trabalho na Fiocruz em tempos de pandemia*, tema tratado pelo psicólogo do trabalho da Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, Marcello Santos Rezende, com a mediação das coordenadoras de nosso projeto, Thaís Máximo e Tatiana Torres. A segunda aconteceu em 9 de dezembro de 2020, com a participação do professor de engenharia de

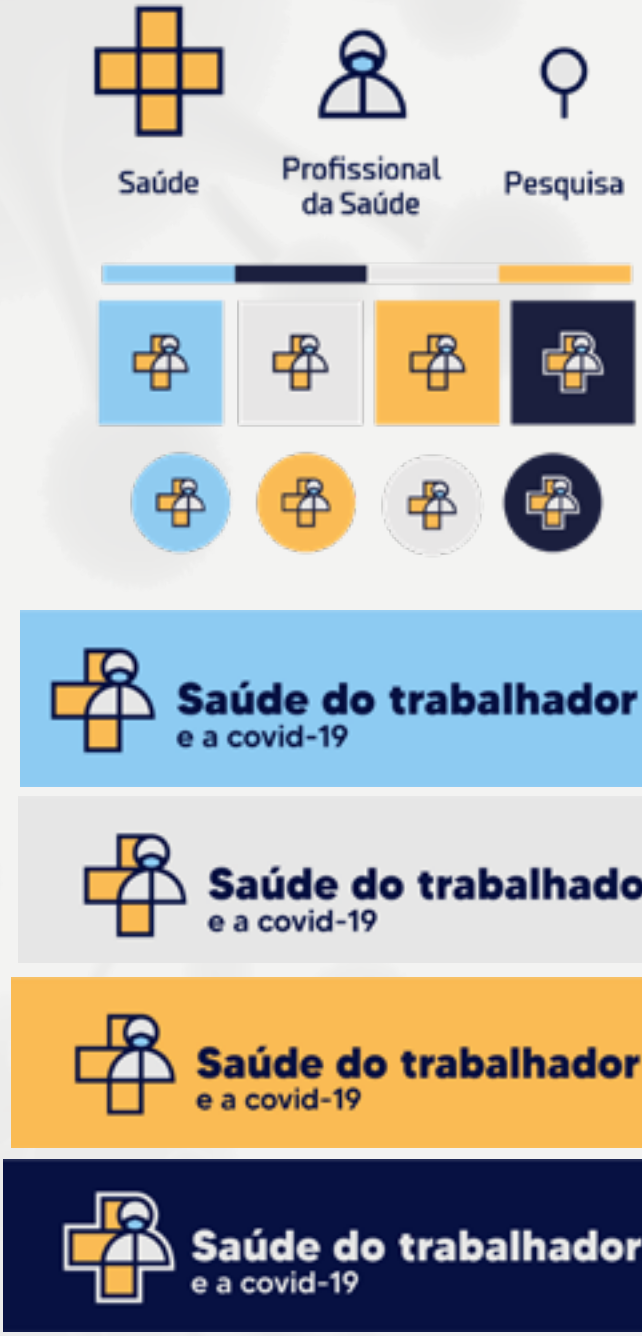
software da Universidade Federal do Ceará, campus Quixadá, Jeferson Kenedy, abordando o tema *Observatórios na área de saúde em tempos de pandemia: características e desafios no Brasil*, e tendo a mediação dos coordenadores de TI do projeto, Adson Cunha e Marcus Carvalho.



Ainda no mês de novembro de 2020, entramos em contato com pesquisadores do Nordeste a fim de apresentarmos nossa pesquisa, buscando formar uma rede de contatos da área acadêmica e firmar parcerias, tendo assim auxílio em relação à difusão da pesquisa, sobretudo nos demais estados da região. Tais questões foram tratadas em reunião remota com os pesquisadores que se dispuseram, realizada via *Google Meet*, no dia 4 de dezembro de 2020.

Logomarca e identidade visual

De setembro a dezembro de 2020, ocorreu o processo de criação de nossa logomarca e identidade visual, desenvolvidas pelas Empresas Juniores dos Cursos de Design da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande, que lançamos e passamos a utilizar nos primeiros dias de janeiro de 2021, em nossas redes sociais, materiais gráficos e digitais.



Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, o trabalho da Comunicação esteve principalmente voltado à divulgação do Estudo I, com o intuito de ampliar o número de respondentes do questionário *on-line*, aplicado remotamente com trabalhadores da saúde do Nordeste atuantes junto ao SUS no enfrentamento à covid-19. Realizamos contatos com entidades, pesquisadores, imprensa e ações em nossas redes sociais, que também foram canal de difusão de outros conteúdos sobre trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores da saúde, como a campanha Janeiro Branco, voltada para os cuidados com a saúde mental, e informações relacionadas à covid-19.

No momento, está em desenvolvimento o *site* oficial do projeto, trabalho que vem sendo realizado em colaboração entre os núcleos de Tecnologia da Informação e de Comunicação, ainda sem data definida para lançamento.

Processo de desenvolvimento: Status Report #1



Como parte do projeto, será desenvolvido um observatório *web,* no qual serão apresentadas informações e resultados das pesquisas sobre a saúde e as condições de trabalho dos trabalhadores da saúde da região Nordeste que atuam na linha de frente no combate à covid-19. Será desenvolvido também um aplicativo *mobile* para que os trabalhadores da saúde possam inserir dados no observatório.

O desenvolvimento do projeto será baseado no *framework* de gestão ágil SCRUM. Através da abordagem, será possível um desenvolvimento iterativo e incremental do observatório e aplicativo de modo que haja um *feedback* constante da evolução das soluções. Os requisitos do projeto serão mantidos no *backlog* do produto, que será atualizado constantemente pela equipe com o nome, importância, estimativa de desenvolvimento e como será demonstrada cada funcionalidade.

Serão realizadas *sprints* (iterações) de duas semanas, cada qual com um objetivo previamente definido, nas quais serão desenvolvidas as funcionalidades de acordo com a prioridade dada pela Coordenação e estimativa de desenvolvimento sugerida pela equipe do projeto. O acompanhamento das *sprints* será realizado por meio da ferramenta *Trello.* Ao final de cada *sprint,* será realizada uma reunião para apresentação dos resultados e reflexão sobre as lições aprendidas.

A equipe é coordenada por dois professores e formada por um líder técnico, responsável por definir a arquitetura e as tecnologias, além de gerenciar o time e atuar no desenvolvimento em conjunto com os três bolsistas. Atualmente, a equipe está mapeando os requisitos iniciais do observatório, incluindo um levantamento de outros observatórios existentes, e do aplicativo *mobile*, além da construção do *site* do projeto. Em paralelo, a equipe está definindo os processos para possibilitar o desenvolvimento distribuído das soluções.



Tecnologias

Foi realizada uma investigação para definir as tecnologias que serão usadas no desenvolvimento do aplicativo *mobile* e observatório *web*, sendo escolhidas as seguintes:

- ***Front-end mobile:*** *Flutter* para aplicativo *mobile*
- ***Front-end web:*** *ReactJS* para interface do observatório
- ***Back-end:*** *Django/Python* para servidor de API REST
- **Banco de dados:** *PostgreSQL* para gerência dos dados.



APLICABILIDADE PARA O SUS



Partindo desses resultados preliminares, já começamos a identificar alguns aspectos que podem auxiliar em termos de aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde, no enfrentamento à pandemia:

1) no estudo do mapeamento, identificamos dificuldades de acesso e padronização dos dados divulgados nos diferentes estados do Nordeste, no que se refere às notificações de casos e casos de contaminação em trabalhadores da saúde. Entendemos que seria interessante um esforço de articulação entre os mesmos, criando, talvez, uma plataforma integrada de acesso às informações da covid-19, principalmente entre as diferentes categorias profissionais da saúde;

2) no estudo da revisão sistemática, observamos a necessidade de divulgação dos estudos sobre os trabalhadores da saúde que vêm sendo feitos no Brasil. Para tanto, uma possibilidade seria o incentivo à publicação de números especiais sobre a covid-19, com editais de apoio às revistas científicas, lançados pelo Ministério da Saúde, que poderiam se somar a eventos pensados pelo Ministério no sentido de compartilhar estudos e experiências de pesquisadores no enfrentamento à pandemia e sobre a saúde dos profissionais da saúde. Também achamos interessante a possibilidade de unificar o acesso a diferentes materiais científicos que vêm sendo construídos por diferentes instituições no país, tais como cartilhas, guias de orientação etc., para que estados e municípios pudessem utilizá-los em suas práticas de gestão em saúde. Verificamos que existe muita riqueza de material, porém, estes estão difusos, causando dificuldade na sua efetiva utilização na política de saúde;

3) com relação aos dados do primeiro estudo, já identificamos necessidades de que haja uma maior atenção e cuidado ao trabalhador da saúde, principalmente neste

contexto de pandemia. Os trabalhadores relataram poucos treinamentos e questões de preconceito por parte da sociedade, de amigos e vizinhos, que se afastaram deles com medo da contaminação. Isso nos mostra uma contradição social, pois enquanto os mesmos estavam sendo glorificados, com palmas, como super heróis; por outro lado, estavam sendo excluídos pela natureza de seu trabalho. Desejamos aprofundar esses dados nos nossos estudos posteriores, mas se faz necessária uma atuação mais efetiva das políticas de saúde, em diferentes frentes, para cuidar desses trabalhadores.



REDES SOCIAIS E CONTATOS

Instagram: @saudedotrabalhador_covid19

Facebook: fb.com/saudedotrabalhadorcovid19

E-mail: saudedotrabalhador_covid19@cchla.ufpb.br

Telefone/WhatsApp: (83) 99602-2443

Endereço: Departamento de Psicologia – Universidade Federal da Paraíba – CCHLA – Bloco Humanístico, Campus I – Castelo Branco I, João Pessoa – PB, CEP. 58051-900





